2023病毒性角膜内皮炎共识｜内容提取表

期刊p13–19＝PDF第1–7页。共识意见无正式推荐等级；单篇研究转述单独标注。

编号	主题	内容摘录	性质／来源	缺项与注意
E01	适用范围	病毒性角膜内皮炎的临床诊疗；常见病原为HSV、VZV、CMV。原文不是适用于所有情形的强制医疗标准。	共识正文 2023 p14 PDF第2页	明确年龄适用边界：原文未明确；专家意见适用性声明见p17
E02	诱发因素	全身免疫力下降、劳累/熬夜/感冒/精神压力、糖皮质激素或免疫抑制剂、月经期；眼部手术及局部长期激素/免疫抑制。	共识正文 2023 p14 PDF第2页	无正式危险评分
E03	临床表现	多为单眼。角膜基质水肿、水肿区域KP、后弹力层皱褶最常见，可有轻度前房反应、虹膜改变、眼压升高、角膜知觉减退。	共识正文 2023 p14 PDF第2页	不能仅凭眼红确诊
E04	临床诊断	符合诊断依据1（病史和诱因）和3（临床体征），可进行临床诊断。	共识诊断标准 2023 p15 PDF第3页	依据1描述急性起病及可能存在病毒感染/病史/免疫下降诱因
E05	病因诊断	符合依据1、3和4或5：4为IVCM辅助检查；5为PCR病毒阳性。原文称发现猫头鹰眼样改变可明确诊断CMV角膜内皮炎。	共识诊断标准 2023 p15 PDF第3页	按原文保留IVCM表述；不是把所有IVCM异常都视为病原确证
E06	临床分型与风险	盘状最常见；弥漫性较少见；线状罕见、内皮细胞丢失最快、最严重，易内皮失代偿；扇形界限清楚，无进展性线状KP。	共识正文 2023 p15 PDF第3页	正式危险分层、内皮细胞密度切点、转诊时限：原文未明确
E07	病原线索	CMV多为线状/扇形、钱币样KP、常眼压高，IVCM可见猫头鹰眼；HSV多盘状，也可弥漫、伴基质水肿/虹膜炎；VZV四型均可、皮损可有可无、虹膜萎缩/瞳孔变形。	共识正文 2023 p15 PDF第3页	线索不能代替病因标准
E08	IVCM与内皮评估	IVCM提供形态和内皮细胞计数，用于评价密度变化、监测进展和预后；CMV猫头鹰眼多位于钱币样KP处。	共识正文 2023 p14 PDF第2页	计数阈值：原文未明确

2023病毒性角膜内皮炎共识｜内容提取表

期刊p13–19＝PDF第1–7页。共识意见无正式推荐等级；单篇研究转述单独标注。

编号	主题	内容摘录	性质／来源	缺项与注意
E09	房水PCR	检测房水病毒DNA/RNA、明确病毒种类。缓解期阳性率不高，阴性不能排除病毒感染，应结合临床。	共识正文 2023 p14 PDF第2页	跨至p15；病毒载量/Ct阈值及重复采样间隔：原文未明确
E10	抗体补充	房水病毒特异性抗体为PCR的重要补充；IgM提示近期感染，IgG提示远期感染；必要时结合Goldmann-Witmer系数。	共识正文 2023 p15 PDF第3页	G-W系数数值切点：原文未明确
E11	鉴别诊断	病毒性前葡萄膜炎、基质炎、内皮失代偿、Fuchs、Chandler、移植后排斥、急闭发作。移植排斥线多在植片内，病毒性KP可跨植片/植床交界。	共识正文 2023 p15 PDF第3页	跨至p16。急闭描述50~60 mmHg为鉴别线索，并非本病治疗阈值
E12	治疗原则	眼部及全身抗病毒，联合眼部糖皮质激素抗炎；按伴随情况对症，目标为控病毒、控炎症、减损伤、保护视功能。	共识正文 2023 p16 PDF第4页	不得将激素单独作为该治疗原则
E13	局部更昔洛韦	0.15%眼用凝胶或0.1%滴眼液，治疗4~6次/d；病变痊愈后巩固2次/d，持续2~4周。阿昔洛韦滴眼液对CMV无效。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	阿昔洛韦滴眼液具体浓度/频次：原文未明确
E14	成人阿昔洛韦	200 mg/次，5次/d，共7 d；缓解后原句为“可减少至诱导剂量，400 mg/d，共4~6个月”。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	原文“诱导剂量”措辞照录；不能改为400 mg/次
E15	成人伐昔洛韦	500 mg/次，2次/d，共7 d。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	儿童方案：原文未明确
E16	成人更昔洛韦	诱导：口服1 g/次，3次/d，共14 d；或慢速静滴250 mg/次，1次/12 h，共14 d。维持：口服0.5 g/次，3次/d，共2个月。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	仅按本共识原文；未另行替换或补足个体方案

2023病毒性角膜内皮炎共识｜内容提取表

期刊p13–19＝PDF第1–7页。共识意见无正式推荐等级；单篇研究转述单独标注。

编号	主题	内容摘录	性质／来源	缺项与注意
E17	成人泛昔洛韦	口服0.25 g/次，3次/d，共7 d；肾功能不全按肾功能调整用法用量。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	调整表/儿童方案：原文未明确
E18	儿童抗病毒	阿昔洛韦诱导：10~15 mg/(kg・d)，共7 d，分3~5次。更昔洛韦诱导：5 mg/(kg・次)，2次/d，共14 d；维持：5 mg/(kg・次)，1次/d，共2个月。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	两种儿童给药途径原文未明确；不补为口服或静滴
E19	按病原选药	HSV以全身/眼部阿昔洛韦或更昔洛韦为主；CMV全身和眼部首选更昔洛韦、易复发者适当延长；VZV全身更昔洛韦/泛昔洛韦或更高剂量阿 昔洛韦，局部更昔洛韦。	共识用药建议 2023 p16 PDF第4页	跨至p17；VZV更高阿昔洛韦的确 切剂量：原文未明确
E20	2%更昔洛韦研究	共识引述文献[36]称2%更昔洛韦滴眼液可增加房水有效药物浓度、主要用于CMV；文献[36]为Keorochana与Choontanom（2017）关于临时配制2%更昔洛韦滴眼液用于CMV前葡萄膜炎的研究（参考文献列于p19）。原文称国内尚无高浓度成品。	共识引述单篇研究 2023 p16 PDF第4页	仅为共识转述，未独立核验该研究全文；不补浓度配制方案/频次
E21	阿昔洛韦肾脏注意	可致急性肾衰，静滴过快增加风险，应减慢滴速；肾功能损伤患者应避免使用。CMV缺少胸苷激酶，阿昔洛韦对其无治疗作用。	共识用药注意 2023 p16 PDF第4页	成人静滴剂量/滴速及肾功能调整切点：原文未明确
E22	更昔洛韦实验室监测	用前查血常规和肝肾功能。诱导期血常规每隔3 d、肝肾每周；维持期血常规每周、肝肾每2~4周。	共识用药注意 2023 p16 PDF第4页	须使用粒细胞而非把阈值写成白细胞
E23	更昔洛韦停药阈值	肝肾功能恶化；血小板≤25×10^9/L；粒细胞≤0.5×10^9/L，或降至用药前的50%。骨髓移植患者慎用。	共识用药注意 2023 p16 PDF第4页	原文未明确肝肾恶化的数值定义
E24	无效/耐药与二线	更昔洛韦治疗3周无效，考虑耐药毒株感染或继发耐药，改用膦甲酸钠。膦甲酸钠为耐药疱疹二线，需静脉给药、可有严重肾不良反应， 充分水化降低肾毒性。	共识用药注意 2023 p16 PDF第4页	膦甲酸钠剂量、疗程、水化量：原文未明确

2023病毒性角膜内皮炎共识｜内容提取表

期刊p13–19＝PDF第1–7页。共识意见无正式推荐等级；单篇研究转述单独标注。

编号	主题	内容摘录	性质／来源	缺项与注意
E25	眼部激素	有效抗病毒基础上，1%醋酸泼尼松龙滴眼液或妥布霉素地塞米松滴眼液4次/d；必要时夜用妥布霉素地塞米松眼膏。羊脂状/尘状KP消退后渐减，每周减少1次，减至1次/d后按炎症决定低浓度激素。监测眼压。	共识用药建议 2023 p17 PDF第5页	低浓度例：氯替泼诺或0.1%氟米龙；具体后续频次/疗程：原文未明确
E26	眼压管理	伴眼压升高需降眼压，恢复正常后减量/停药；慎用前列腺素类，以免加剧前房炎症和增加复发风险，并注意各药禁忌。	共识用药建议 2023 p17 PDF第5页	干预阈值、目标眼压、具体降眼压药剂量及完整禁忌清单：原文未明确
E27	移植及复发	严重内皮失代偿需角膜移植/内皮移植；围手术期充分抗病毒，术后全身抗病毒通常3~6个月，定期血常规/肝肾复查。避免劳累、感冒，加强锻炼。	共识建议 2023 p17 PDF第5页	手术具体时机和非药物预防强度：原文未明确
E28	随访与特殊人群缺项	原文给出内皮密度变化、炎症/眼压关注及药物实验室随访，但未给统一门诊复诊日程、妊娠/哺乳方案、成人肾功能调整表、正式推荐等级。	原文缺项 2023 p17 PDF第5页	完整原文p13~19核查；不补编

拟定流程与使用边界

1. 依据1（急性起病；感染史/诱因可有）及依据3（基质水肿、水肿区KP、后弹力层皱褶）→ 临床诊断（2023，p15）。

2. 核对鉴别诊断 → 前房/虹膜炎为主、Fuchs/Chandler、移植排斥、急闭等；不把急闭50~60 mmHg当作本病干预阈值（2023，p15~16）。

3. IVCM + 房水PCR；必要时特异性抗体/G-W系数 → 病因标准按1、3及4或5；PCR阴性不能排除（2023，p14~15）。

4. HSV：阿昔洛韦或更昔洛韦；CMV：首选更昔洛韦；VZV：更昔洛韦/泛昔洛韦或更高剂量阿昔洛韦，后者确切剂量原文未明确（2023，p16~17）。

5. 同时按条件分支：在有效抗病毒基础上联合眼部激素；眼压升高则降眼压；线状型/内皮损伤注意进展，严重失代偿评估移植（2023，p15、17）。

6. 更昔洛韦治疗前与诱导/维持期按原文验血；达到停药指征则停药；治疗3周无效考虑耐药并改用膦甲酸钠，剂量原文未明确（2023，p16）。

7. KP消退→激素每周减少1次；眼压正常→降眼压药减停；复发/术后按原文延长抗病毒和监测。统一眼科复诊间隔原文未明确（2023，p17）。

危险评分、住院/转诊标准、PCR/G-W/眼压处置阈值、统一复诊间隔：原文未明确。

药物数字按2023原文；“400 mg/d”不能改成400 mg/次。儿童给药途径不补编。

2%更昔洛韦信息为共识引述单篇研究[36]（CMV前葡萄膜炎），未独立核验其全文。

眼科复核后使用；个体处方需同时核对适应证、肾功能及现行药品说明书。